AI WEB 网页开发挑战赛

MedAI

草地上的绒球医生 —— 给每个家庭的一份健康档案

技术文档

参赛院校	广东医科大学
参赛组别	B 组（本科）
团队成员	陈妍萱、潘思妍
指导教师	白金山
联系方式	13215101646
完成日期	2026 年 10 月

目录

01 项目概述 3

02 需求分析 5

03 系统架构设计 7

04 AI 技术方案 9

05 核心功能实现 12

06 创新点说明 15

07 测试与部署 17

08 总结与展望 19

附 附录：引用说明 · 运行方式 · 演示账号 22

一句话说明这个作品在做什么。 MedAI 是一个面向普通家庭的健康档案与 AI 问诊工具：一个账号管全家人的档案，把"该吃什么药、 该不该去医院、复诊时怎么跟医生说"这三件最日常也最容易出错的事，放在一片能点开的草地上。 它不替代医生 —— 只做记录、提醒、翻译和整理。

项目速览	内容
形态	Web 应用（桌面 / 移动端响应式），可离线私有化部署
技术栈	Next.js 16 + React 19 + TypeScript 5.9 + Three.js 0.170 + Prisma 6 + SQLite
AI 能力	DeepSeek 流式问诊 + 个体化提示词装配 + 11 条本地红旗规则 + 事实核对
内容规模	90 条疾病科普 • 73 种药品说明 • 13 个科室 • 18 组自绘 SVG 插图
代码规模	约 2.7 万行（TS / TSX / JS，不含依赖与构建产物）• 23 个 API 路由
自检覆盖	接口 68 项 • 木牌 33 项 • 提醒 20 项 • 登录 18 项 • 入口 8 项，全部通过

01　项目概述

1.1 作品简介

MedAI 面向"一个家里谁在管药"这件事。它把家庭成员的档案、在服药物、问诊记录、就诊摘要 收在一个账号里，用一片可以点开的 3D 草地作为入口：家里每个人是一块小牌子，点开就能对话； 天上吊着一块木板，写着全家今天吃了几次药，点一下就能打卡。

产品的边界写得很清楚：不做诊断、不开处方、不替用户判断"哪句话重要"。 AI 只承担三件事 —— 把专业术语翻译成人话、把散落的信息整理成可执行的动作、 把一次问诊整理成一张能带去医院的纸。判断权始终在患者手里。



图 1　草地首页：左栏是家人的档案，天上吊着用药木牌，绒球医生会看着鼠标

1.2 背景与意义

中国有超过 3 亿的慢性病患者，其中相当一部分是老年人；与此同时，"一个家庭里谁在管药"这件事， 通常落在家里那个二三十岁的年轻人身上。他要记得父母各吃什么药、哪天该复诊、孩子发烧到多少度该去医院，还要在下班后替父母把"医生说的一堆话"翻译成能执行的动作。

这件事的难处不在于信息不够，而在于信息散落在药盒、纸质病历、微信聊天记录和老人的记忆里。 家里老人吃几种药，子女往往说不全；上一次问诊医生说了什么，一周后基本只剩一句"多喝水"。

现有工具为什么没解决

现有形态	它做到的	它缺的
手机闹钟 / 药盒提醒器	到点响，便宜、可靠	只知道"该吃药了"，不知道"谁该吃、吃几片、吃没吃"；换个人就全乱
医院 App / 互联网医院	能挂号、能复诊、有电子病历	每家医院一套，跨院不通；面向"这一次就诊"，不面向"这一年"
通用 AI 聊天	什么都能问，门槛低	没有档案就没有个体化；不了解过敏史、在服药物，建议只能停在科普层面
健康管理类 App	功能齐全、数据维度多	要填的太多，老人用不了；界面像体检报告，看不下去

结论是：缺的不是功能，而是一个"全家共用、一个人维护、老人也看得懂"的容器。 这个容器还必须解决一个矛盾 —— 数据要共享（全家人看得到），隐私不能共享（别人一份都看不到）。

1.3 应用场景与目标用户

角色	是谁	他真正在意的一件事
主要使用者	25 – 45 岁，家里管事的那个子女	爸妈今天吃药了没有；孩子夜里发烧要不要去急诊
被照护者	父母（多为慢病）、老人、儿童	不想学新东西；只想知道"现在该干什么"
次要使用者	异地子女、家庭护工	不在身边也能看到今天的情况

场景一：早上七点，厨房。手机在灶台边响了一声，兔子在草地上说"该给妈妈吃降压药了"。 用户腾不出手，就把手机架起来点了一下木牌上那一行 —— 打卡完成，板子上的 2/5 变成 3/5。 整个过程两个动作，不用进任何二级页面。

场景二：夜里十一点，孩子发烧。用户打开草地，点孩子的牌子问"39 度，一直哭，要不要去医院"。 系统先做本地红旗判断（有没有抽搐、意识不清、皮疹），再结合档案里的年龄体重和在服药物回答， 最后给出一张可以带走的就诊摘要。

场景三：复诊前一晚。用户点开"病程时间轴"，把这三个月发生的事排成一条轴： 哪天开始吃药、聊过几次、结论卡片写了什么。点"投影视图"，铺成一张白纸，截图或打印， 第二天直接给医生看 —— 不用再凭记忆复述。

三个场景都发生在手机上，而且经常是"一只手、几秒钟、注意力被打断"的状态。 这直接约束了设计：主操作必须在首屏一次点击内完成；文字要大到在油烟和昏暗里也能读； 动画必须能在中低端安卓机上跑得动（见 7.4 性能取舍）。

02　需求分析

2.1 五类真实问题

问题	现实里的样子	我们的做法
吃了没记	"今天这顿到底吃没吃"—— 老人记不清，子女问不出来，重复服药风险由此产生	天上那块木牌：全家今天的用药一屏看完，每一行就是打卡按钮，点一下记为已服、再点撤销，行内状态与板面文字同时变
该不该去医院	胸痛、呼吸困难、意识不清这类信号，被"再观察观察"耽误；反过来，普通感冒又容易过度就医	红旗症状交给本地规则而不是模型：11 条正则命中即中断问诊，画成红卡片并落库， 刷新之后还是红的
说不清病史	复诊三分钟，医生说"上次那个药还吃着吗"，患者答不上来	把档案、在服药物、最近 3 次问诊摘要、8 条结论拼成个体化提示词；并把一次问诊整理成 可打印的就诊摘要
听不懂医嘱	"窦性心律""幽门螺旋杆菌"—— 名词听懂了，但不知道该做什么检查、什么说法是谣言	内置 90 条疾病 + 73 种药品科普，疾病详情里专门有"去医院一般会做哪些检查"和 "流传很广，但不对"两节
既想共享又怕泄露	全家人的健康数据放在一个 App 里，谁都能看，等于没有隐私	一个账号多份档案，所有读写都用 `ownerId` 在一条 SQL 里挡掉越权； 别人的档案和不存在返回同一个 404

2.2 功能需求

上面五类问题拆成 6 组功能需求。优先级里 P0 是"不做就等于没做"， P1 是"没有它产品不完整"，P2 是"有更好"。

编号	功能组	优先级	具体要求
FR-1	账号与数据隔离	P0	注册 / 登录 / 登出；一个账号管多份家庭档案；跨账号的任何读写都必须返回 404 而非 403
FR-2	家庭档案	P0	姓名、关系、生日、身高体重、过敏史、既往史、主诉；可编辑、可删除；支持头像
FR-3	用药与打卡	P0	用药计划（药名、剂量、频次、起止日期）；今日待服清单；打卡与撤销；全家用药板一屏呈现
FR-4	AI 问诊	P0	流式对话；回答必须结合档案与在服药物；高危症状必须被拦截并给出就医指引；不出现诊断与处方
FR-5	科普库	P1	疾病与药品检索；疾病含检查项目与常见误区；药品含起效时间、漏服处理、储存条件
FR-6	就诊材料	P1	病程时间轴；就诊摘要（可打印、可复制纯文本）；复诊日历

FR-7	资料上传	P2	化验单 / 处方照片 / PDF / Word 上传；本地 OCR；文本可作为对话附件上下文

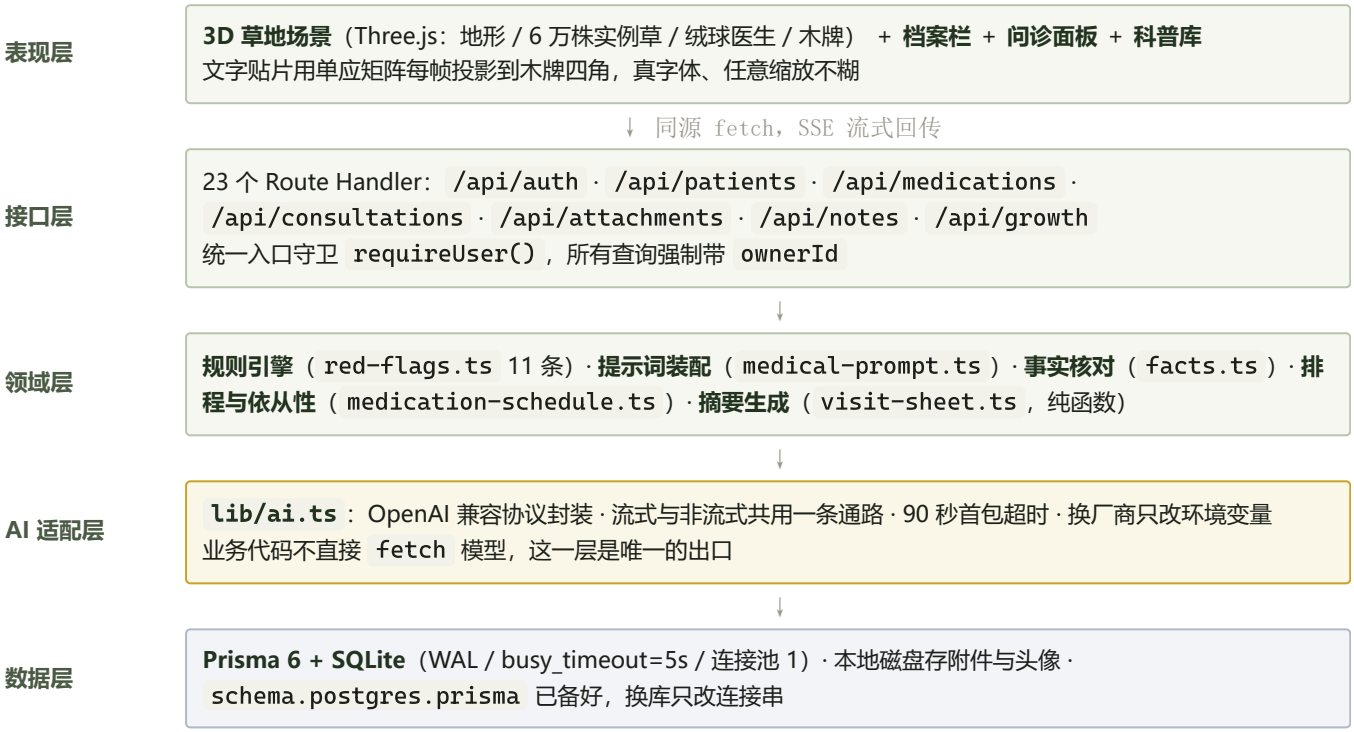
2.3 非功能需求

维度	指标	怎么落地
响应速度	首屏可交互 < 2.5s（4G 中端机）；红旗判断 < 200ms	3D 模型加载前有程序化占位体；红旗规则纯本地正则，不经网络与模型
渲染性能	移动端稳定 30fps 以上	草用实例化渲染（一次 draw call 画 6 万株）；`devicePixelRatio` 封顶 1.5
安全	密码不可逆、会话可验签、上传不可执行	scrypt 加盐哈希；HMAC 签名 Cookie；上传只校验文件头魔数，文件名由服务端生成
隐私	健康数据不外泄，对话不长期留存	数据隔离在 SQL 层完成；对话原文 30 天清理；密钥只在服务端环境变量
合规	不诊断、不开方、不替代面诊	系统提示词硬约束 + 每条科普页固定"科普不替代面诊" + 红旗强制转诊
可维护	换模型 / 换数据库不改业务代码	AI 收敛在 `lib/ai.ts` 一层；数据层换 `DATABASE_URL` 即可切 Postgres
可部署	断网环境可独立运行	字体、模型、OCR 语言包全部本地化，无第三方 CDN 依赖；47MB 离线包解压即跑

03　系统架构设计

3.1 总体架构

整体是"单页壳 + 服务端路由 + 一层 AI 适配"的结构。浏览器侧只有一片草地和一个问诊面板， 状态集中在 `MeadowStage.tsx`；服务端 23 个 API 路由按 "校验输入 → 认门 → 查配置 → 干活"的固定顺序处理，任何一步不过就直接返回。



3.2 技术栈与选型理由

层	选型	为什么是它
框架	Next.js 16（App Router）+ React 19 + TypeScript 5.9	同一仓库里既有服务端取数也有客户端交互；Server Component 让档案数据在服务端就按 ownerId 过滤完，不下发整表
样式	Tailwind 4 + 手写 CSS 变量	3D 转场、木牌投影这类效果需要精确的时间轴和矩阵，纯原子类反而难写
3D	Three.js 0.170（自写 engine.js）	草地是实例化渲染 + 顶点着色器风摆，通用编辑器做不出来也带不动
数据	Prisma 6 + SQLite	单机自用场景零运维；换成 Postgres 只需改 DATABASE_URL
模型	DeepSeek（OpenAI 兼容协议）	中文问诊语境好、流式便宜；封装层不绑定厂商，换模型只改环境变量
认证	Node 内置 crypto（scrypt）+ HMAC Cookie	不引认证库，少一个供应链风险；逻辑不到 200 行，可逐行审

OCR	tesseract.js + 本地中文语言包	化验单不该上传到第三方识别服务；语言包随仓库走，断网可用

3.3 模块划分

模块	职责
`lib/auth.ts`	scrypt 加盐哈希、HMAC 会话、`requireUser()`
`lib/medical-prompt.ts`	把档案 / 在服药物 / 摘要 / 结论拼成个体化 System Prompt，带三个 token 上限
`lib/red-flags.ts`	11 条红旗症状正则，命中即中断，不经过模型
`lib/facts.ts`	`diffFacts()` 用代码判定冲突，`applyFacts()` 重新校验后落库
`lib/visit-sheet.ts`	就诊摘要的结构、清洗、本地模板与纯文本版（纯函数，无副作用）
`lib/medication-schedule.ts`	排程展开与依从性计算，漏服封顶 7 天
`lib/knowledge-search.ts`	中文检索：归一化 + 多词 AND + 字段权重打分
`components/meadow/engine.js`	3D 场景：地形、实例草、绒球医生、木牌布局与投影
`lib/ai.ts`	模型调用的唯一出口

3.4 数据模型

表	关键字段	说明
User	email • passwordHash	账号，所有数据的根
Patient	name • gender • birthday • allergy • history • chiefComplaint	家庭档案，一个账号可多份
Medication	name • dose • frequency • startDate • isActive • reminderAt	在服药物与提醒时间
CheckIn	medicationId • dateKey • takenAt	一天一次打卡，(medicationId, dateKey) 唯一，重复打卡幂等
Consultation	status • lastMessageAt • summary	一次问诊会话，关闭时归档
Message	role • content • flag • attachmentId	红旗消息把 `redflag.<kind>` 写进 flag，刷新后仍红
Note	content • starred	结论卡片，只有患者能建
Attachment	path • mime • size	化验单 / 处方照片，30 天清理

04　AI 技术方案

4.1 选型理由

这一层是本作品权重最高的部分，也是做取舍最多的地方。三个选题决定了技术路线： 要不要微调、要不要向量库、要不要 Agent 框架。

（1）为什么用提示词个体化，而不是微调

微调适合"改变说话风格与任务格式"，不适合"让模型知道某个具体患者的过敏史"。 后者属于事实注入，用提示词就能做到，而且改了立刻生效 —— 患者今早刚加的青霉素过敏，下午的对话就必须带上，微调模型做不到这个时效。 另外微调需要构建数据集并承担训练成本，一个家庭的数据量根本不支持。 所以路线是：通用模型 + 结构化事实装配 + 硬约束提示词。

（2）为什么没上向量 RAG

科普库是 90 条疾病 + 73 种药品的结构化条目，不是长文档。 这类语料的关键是"准确命中条目"，而中文病名的检索难点在别名与错别字 （"胃食管反流"与"烧心"、"甲亢"与"甲状腺功能亢进"），不在语义近似。我们用"全半角与简繁归一 + 同义词映射 + 多词 AND + 字段权重打分"解决了命中问题： 病名权重高于症状描述，命中病名即置顶。零依赖、可解释、结果稳定，比引入 embedding 模型和向量库更划算 —— 后者还会带来一个几百 MB 的运行时依赖， 与"离线可部署"这条非功能需求冲突。

> 这一点在文档里说清楚，比含糊地说"实现了 RAG"更重要。 我们没有做向量检索，做的是检索增强的关键词方案：检索结果作为事实注入提示词， 模型在此基础上组织语言。它的增强效果来自"命中准"，而不是"语义泛化"。

（3）为什么不用 Agent 框架

问诊是线性对话，不需要多步规划与自主决策。引入 Agent 框架会带来两个风险： 一是模型可能自行决定"再问一轮"或"直接给结论"，行为不可预测； 二是每一轮工具调用都增加延迟与费用，而用户是在深夜着急地问"要不要去医院"。 我们选择把"决策"写成确定性代码（红旗规则、冲突判定、排程）， 只在"组织语言"这一步交给模型 —— 慢的地方必须快，不确定的地方必须确定。

4.2 集成方式

环节	做法
调用位置	只在服务端。密钥存在 `.env` 的 `DEEPSEEK_API_KEY`，浏览器永远拿不到
协议	OpenAI 兼容的 `/chat/completions`，`stream: true`；服务端转成 SSE 推给前端
封装	`lib/ai.ts` 抽出 `postChat()`，流式与一次性调用共用；换厂商只改 baseURL 与 model
失败处理	先调模型，流读完且内容非空，才把提问和回答一起写库；Key 错、上游 500、网络断都不会攒出"只有提问没有回答"的记录

降级	无 Key 时 `MEDAI_DEMO_AI=1` 走本地模拟流，协议与真实调用一致，全链路可演练；就诊摘要另有本地模板兜底，绝不空手

4.3 提示词工程

每次对话前拼四样东西：① 档案（年龄、体型、血型、过敏史、病史、习惯、主诉） ② 在服药物 ③ 最近 3 条问诊摘要 ④ 星标优先的 8 条结论。 这四块各自有 token 上限，总量恒定，不会随对话变长而失控； 超出上限时按"过敏史 > 主诉 > 在服药物 > 摘要 > 结论"的顺序裁剪，把最后的位置留给最重要的信息。

医疗合规三件套永远在场：不下诊断、不开处方；过敏史优先考虑并主动提醒； 涉及处方药必须提示遵医嘱。这三条写在系统提示词最前面，并且不参与裁剪。

4.4 优化策略

优化点	做法	效果
规则前置，先拦后问	红旗症状在调模型之前用本地正则判定	拦截耗时 126ms，走模型 1646ms；省一次调用，且模型挂了这条生命线照样生效
首包超时而非全程超时	只给"建连 + 首包"设 90 秒上限，拿到响应头就撤计时器	话多的正常回答不会被从中间掐断；网络卡死时又不会无限等
流式渲染	SSE 逐块推，前端边收边画	首字出现时间从数秒降到 1 秒内，长回答的体感差异明显
本地能力不上云	红旗判定、排程计算、科普检索、OCR 全在本地	这三类调用量最大，本地化后不产生费用，也不受上游可用性影响
事实核对人工闭环	模型只返回候选事实，一个字不写库；冲突项默认不勾选并红色高亮	避免模型"顺着用户说"污染档案，同时把确认成本降到一次点击

4.5 AI 安全与可控

（1）红旗症状不走模型

11 条规则覆盖胸痛、言语不清、抽搐、意识改变、大出血、呼吸困难、高热伴皮疹等急症表述。 命中即中断常规回答，改为固定话术要求立即就医或拨打 120。命中结果写进消息的 `flag` 字段（`redflag.<kind>`），刷新之后仍然是红的 —— 安全提示不能被一次页面刷新冲掉。



图 2　红旗拦截：命中后不再走常规问诊，改为红卡片强制就医指引

(2) AI 提建议，患者点头

模型只能返回候选事实（可补字段 / 新增用药 / 与档案冲突）。 其中 `fill` 与 `add` 默认勾选，`conflict` 默认不勾选并红色高亮， 必须患者亲手确认。冲突判定由代码完成，不交给模型 —— 让模型判断"新信息与档案是否矛盾"， 它容易顺着用户说。落库前每条都当不可信输入重新校验：字段白名单、长度上限、 单次 ≤ 20 条、`medicationId` 按 ownerId 重查。

> 一条自我约束：结论卡片（Note）不许自动生成。 客观事实可以让 AI 整理，但"哪句重要"是价值判断 —— 只有患者自己知道。 这个取舍让产品少了一个看起来很酷的功能，但保住了"判断权在人手里"这条线。

05　核心功能实现

5.1 信息架构

一层	内容
草地（首页）	家人档案栏 • 今日用药木牌 • 绒球医生 • 疾病科普 / 药品说明两个入口
档案详情	基本信息 • 在服药物 • 结论卡片 • 问诊记录（日历） • 病程时间轴 • 成长记录
问诊面板	流式对话 • 附件（图片/PDF/Word） • 事实核对 • 就诊摘要
科普库	疾病 90 条（13 科室） • 药品 73 种（10 大类） • 症状搜索

5.2 视觉与交互基调

医疗类产品的默认语言是"白底 + 蓝 + 表格"，它传达的是准确，但也传达距离感。 MedAI 选择的是另一种可信：一片有风的草地、一只毛绒绒的绒球医生、一块手写的木板。 颜色取自清晨的草地（`#8abfeb` 的天空、`#2f4a2b` 的深绿、奶油色的纸面板）， 圆角与黏土质感的按钮（`.clay`）替代了直角卡片。 目的很实际：让人愿意在深夜打开它。

（1）开场：一株蒲公英

首次进入是一株 186 颗种子的蒲公英（内联 SVG，无图片请求）。吹散之后 3D 草地才显出来 —— 这不是装饰，是用 1.2 秒把"这是一片能玩的地方"这件事说清楚。看过一次后写入 `sessionStorage`，返回时在 HTML 解析阶段就打上标记，第一帧直接隐藏，不会闪回开场。

（2）点开档案：一场三者同步的转场

点一份档案，球向右滚 90°、抬头、缩小，左栏左滑消失，问诊面板从右滑到中间 —— 三者共用一条 `--flow: 1100ms` 的时间轴，同一刻停下，球正好趴在面板上边缘。 球的落点不是写死的坐标，而是把面板的 `offsetLeft/offsetTop` 反投影回 3D 世界算出来的， 换分辨率、换布局都准。转场进度用墙钟计算而不是累加 `dt`：低帧率设备上 `dt` 会被钳到 0.05，那样 1.1 秒会被拖成两三秒，球就和面板错开了。

（3）木牌打卡：把"记录"压缩成一个动作

木牌最初只是"看"的 —— 看全家今天吃到哪了。但看和记之间隔着一个二级页面， 而真实场景里用户根本没空跳转。所以现在卡片里每一行药就是按钮： 点一下调打卡接口，成功后重新拉取整块板子，行内状态、表头计数（2/5 → 3/5）、 3D 板面上的字三处同时更新。



图 3　点一下木板，卡片从板子下面长出来；点行即打卡，三处状态同步

这里有个细节值得一提：打卡后同一个人的名字可能因为排序变化而移动，用户会点错行。 所以卡片打开时会把人名顺序冻结下来，打卡只改状态、不重排。

（4）就诊摘要：能带走的那张纸

问诊结束后可以整理成一张 A4 纸：主诉 / 病程 / 在服药与过敏史 / 现在可以先做的 / 何时必须就医 / 想问医生什么。它单独重排了字号和版式（不依赖 flex、色块用真边框）， 用任何工具转 PDF 都不容易变形；同时提供纯文本版，复制到微信里也不会丢掉过敏史。



图 4　就诊摘要：A4 单页，可打印为 PDF，也可复制成纯文本

5.3 开发过程

项目按"能用 → 好用 → 敢交"三段推进，每一轮都以"自检脚本全绿 + 真实截图"收尾。 代码按模块分 18 次提交入库，提交信息记录每次改了什么、为什么改。

阶段	做了什么	为什么这一步重要
第 1 周	账号体系、档案增删改查、问诊流式对话、AI 提示词装配	先把"能不能用"跑通，此时界面还很朴素
第 2 周	3D 草地（实例化草、风摆、绒球医生）、蒲公英开场、点档案的转场	产品第一次有了"愿意打开"的理由
第 3 周	红旗症状本地规则、事实核对、就诊摘要、问诊日历	把 AI 从"聊天"变成"有边界的工具"
第 4 周	用药提醒、木牌、病程时间轴、疾病/药品科普库	覆盖"吃、看、说"三个真实动作
第 5 周	木牌上直接打卡、404/错误页、演示入口、打包与离线部署	从"能演示"走到"能交付"

5.4 三个修得比较深的问题

（1）低帧率设备上，转场会错位

最初转场进度是把每帧 `dt` 累加。但引擎里 `dt` 被钳到 0.05， 30fps 的机器上 1.1 秒的动画会被拖成两三秒，球和面板就错开了。 改成用墙钟计算进度后，无论多少帧，三者都在同一刻停。

（2）窄屏切回桌面，木牌停在半空

木牌的横向位置取自左栏 `.records` 的右边界，纵向靠相机反投影。 `resize` 那一帧里，左栏还是手机版宽度、相机还在插值 —— 两个输入都是旧的，板子就摆错了地方。 修法是在 resize 后记一个 1.4 秒的重排倒计时，逐帧重摆，等 CSS 和相机都落定。 这条后来写成了回归断言（切回桌面木牌必须回到原位，误差 < 24px）。

（3）打包漏掉了 `.next/node_modules`

分发包解压后 `next start` 报 `Cannot find module`。 原因是排除规则里的 `node_modules` 把 `.next/node_modules` 整棵剪掉了 —— 那是 Turbopack 给 `serverExternalPackages` 留的入口（一堆符号链接）。 改法：只剪项目根下的 `node_modules`，并让遍历跟随符号链接。 这个坑只在"真的解压、真的启动"时才暴露，也是后来坚持做解压验收的原因。

06　创新点说明

6.1 技术创新点

四条，共同点是把"该确定的"从模型手里拿回来，只在模型擅长的地方用它。

创新点	通行做法	我们的做法
T1　红旗症状不走模型	把"是否紧急"也交给大模型判断，靠提示词约束	11 条本地正则规则先判，命中即中断问诊并落库。实测拦截 126ms，走模型 1646ms； 模型挂了也不影响这条生命线
T2　冲突判定用代码，不用模型	让模型自己判断"新信息和档案是否矛盾"，容易顺着用户说	`diffFacts()` 做字段级比对，冲突项默认不勾选、必须人工确认；模型只负责抽取
T3　3D 木牌上贴真字体	把文字烘成贴图，缩放就糊；或者干脆用一块 HTML 浮层假装	板面文字是 HTML，每帧用单应矩阵贴到板子四角 —— 真字体、任意缩放不糊， 还能被子遮挡、跟着板子摆
T4　提醒有两条通道	只依赖系统通知，用户一拒权限功能就废了	先让兔子在草地上说一句、蹦一下，有权限再补一条系统通知；人不在页面上时那句话会存着，回来补上

6.2 应用创新点

三条，共同点是把一个动作的完成成本压到最低，而不是增加功能数量。

创新点	通行做法	我们的做法
A1　打卡压缩到"一行一次点击"	提醒 → 跳详情页 → 找到那颗药 → 点"已服用"	木牌卡片里每行就是按钮，不进二级页面；打卡后行、表头、3D 板面三处同步。 厨房里一只手也能完成
A2　把问诊变成一张能带走的纸	聊完就结束，复诊时患者凭记忆复述	就诊摘要按 A4 重排版式，可直接打印或复制纯文本；病程时间轴还能铺成投影视图给医生看
A3　一个账号管全家，且互不可见	要么一人一号（老人不会注册），要么全部可见（没有隐私）	一个账号多份档案，越权在 SQL 层挡掉；别人的档案与不存在的档案返回同一个 404， 连"这个 id 存不存在"都问不出来

6.3 与同类作品 / 产品的差异

大部分健康类作品的重心在"功能数量"，MedAI 的重心在"一个动作的完成度"： 打卡是两个动作、问诊是一次点击、复诊材料是一张能打印的纸。 另一条差异是边界感：不诊断、不开方、不替用户判断"哪句重要"， 把 AI 放在"整理和翻译"的位置上 —— 这既是合规要求，也是这类产品能长期被信任的前提。

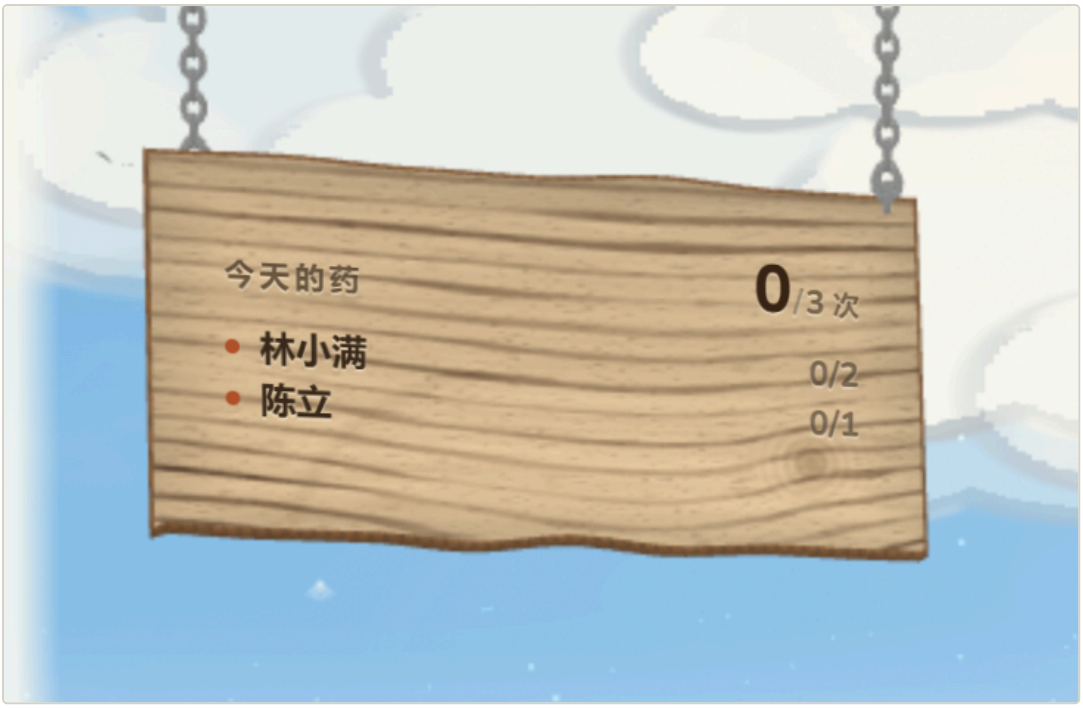


图 5　木牌特写：文字是真字体而非贴图，放大后边缘依然锐利

07　测试与部署

7.1 自检体系

项目没有引入测试框架，但有一套可重复执行的自检脚本，覆盖接口、规则、渲染与交互， 每次改动后跑一遍，输出通过 / 失败计数。当前状态：

脚本	项数	覆盖什么
`scripts/api-test.ts`	68	注册登录、越权、档案 CRUD、用药、问诊、事实核对、附件
`scripts/check-board.mjs`	33	木牌位置、卡片明细、打卡与撤销、三处同步、resize 回归、移动端
`scripts/check-reminder.mjs`	20	提醒时间计算、免打扰、漏服封顶、文案
`scripts/check-login.mjs`	18	登录只有邮箱一条路、Cookie、越权拒绝
`scripts/check-entry.mjs`	8	中文 404、错误页出口、演示入口一步进入
`scripts/knowledge-test.ts`	—	90 条疾病 + 73 种药品的字段完整性与搜索命中（同义词归一）
`tsc --noEmit` / `eslint .`	0 错误	类型与规范

交付前不看清单看行为：解压到独立目录 → `npm ci` → `prisma generate` → `db push` → 起服务 → 跑一遍登录、建档、加药、打卡、科普库。 只有这一遍走通了才算"能交付"。

7.2 安全与隐私

- 密码 scrypt 加盐哈希；会话是 HMAC 签名的 7 天 Cookie，服务端不存 session 表。
- 所有读写用一条语句挡越权（`findFirst({ where: { id, ownerId } })`）， 不做"先查再比对"，避免从响应差异确认某个 id 是否存在。
- 上传只校验文件头魔数（PNG / JPEG / GIF / WebP），文件名由服务器 `randomUUID` 生成，不采信用户文件名。
- 登录限流：按 IP 8 次 / 按账号 5 次，每 15 分钟；成功登录会把计数清零，正常用户不会被误锁。
- 对话原文保留 30 天，到期清理；小结与结论卡片不受影响。
- API 密钥只在服务端环境变量，版本库内不含任何密钥（打包脚本会独立复查一次）。

7.3 部署方案

方式	适用场景	步骤
本机直跑	演示、答辩现场（无需外网）	`npm ci` → `prisma generate` → `prisma db push` → `npm start`； Windows 双击 `Start MedAI.bat` 即可，首次运行会自动补齐这四步

Docker	交付给机构、社区医院	`docker compose up -d`；多阶段构建，产物只留 standalone 所需文件
Caddy 反代	公网在线演示（可选加分项）	Caddy 负责 HTTPS 与反代，容器内只监听内网端口，证书自动申请
离线包	网络受限环境	47MB 离线包（含 .next 与 prisma client）解压即跑，无第三方 CDN 依赖

数据备份用 `npm run db:backup`：WAL 模式下直接 `cp` 会漏掉还在 `-wal` 里的数据，所以改用 `VACUUM INTO` 导出一致性快照，导出后重开校验表存在。

7.4 已知取舍（写在明处）

- 会话无状态：登出会清 Cookie，但旧 token 在到期前仍可用；要做到即时吊销得加黑名单表。
- 头像与附件存本地磁盘：单机部署没问题，多实例要换对象存储。
- SQLite 单文件：适合单机自用，并发写多了要换 Postgres（schema 已备好）。
- 限流是进程内的：起多实例必须换 Redis，注释里写清了。
- 首屏 3D 模型 4.7MB：弱网下兔子会晚出现一两秒，有程序化占位体兜底，不会白屏。

08　总结与展望

8.1 做成了什么

五周时间，做了三件事：一个能管全家的档案容器、一个有边界的 AI 问诊、 一个愿意被打开的外壳。前两件是功能，第三件是这类产品能不能被用起来的前提 —— 一个需要教三遍才会用的健康 App，老人第二天就不会再点开。

技术上最值得记的不是用了什么框架，而是几条约束： 安全判断不交给模型、冲突判定不交给模型、结论生成不交给模型。 这三条让产品的行为可预测、可解释、可审计，代价是少了几个"看起来很 AI"的功能。

8.2 局限

- 没有真实临床验证：科普内容依据公开诊疗指南与说明书整理，未经过医生评审流程。
- 红旗规则覆盖有限：11 条规则能拦住最典型的急症表述，但方言、口语化表达仍可能漏判。
- 单机架构：家庭自用足够，机构规模需要换 Postgres 与对象存储。
- AI 回答质量依赖上游模型：提示词能约束边界，但不能保证每句话都准确。

8.3 推广路径

阶段	对象	怎么用
一、家庭自用	有慢病老人的家庭、有小孩的家庭	一个账号管全家，免费；核心价值是"今天吃药了没有"和"这次要不要去医院"
二、社区 / 家医签约	社区卫生服务中心、家庭医生团队	就诊摘要可以直接作为签约居民的随访材料；医生不用再问一遍用药史
三、机构合作	药企患者服务、慢病管理公司、养老机构	私有化部署（Docker + SQLite/Postgres），数据不出机构

8.4 可持续性

技术上，模型层已经解耦（换厂商只改环境变量），数据层一条 `DATABASE_URL` 就能切 Postgres， 部署有三条路线（本机 / Docker / Caddy 反代）。 成本上，单用户每次问诊的模型开销是可控的（历史 20 条 + 摘要 3 条 + 结论 8 条的固定上限）， 红旗判断、排程、科普检索全部在本地完成，不产生调用费用。

更重要的是它足够小：不依赖任何第三方健康数据接口，一个 47MB 的离线包解开就能跑。 这意味着它可以被送进网络条件一般的社区医院，而不是只能活在演示视频里。



档案 · ARCHIVE

今天有 6 份档案

点开任意一份，绒球医生会从草地上滚过来，
陪你聊完这次问诊。

01 **林小满** 过敏

27 岁 · 女 · 24 次问诊 · 1 种在服药

右上腹隐痛三天，饭后加重

02 **陈立** 过敏

54 岁 · 男 · 1 次问诊 · 1 种在服药

夜间干咳两周，爬楼气短



图 6　移动端：主操作在首屏一次点击内完成，文字在油烟与昏暗里也读得清

附录 A　引用与开源说明

名称	许可 / 性质	用途
Next.js / React	MIT	应用框架与渲染
Three.js	MIT	3D 场景渲染
Prisma	Apache-2.0	ORM 与迁移
Tailwind CSS	MIT	样式工具
tesseract.js	Apache-2.0	化验单 / 处方照片的本地 OCR
Nunito	SIL Open Font License	界面西文字体
DeepSeek API	商业服务	问诊对话与摘要生成
绒球医生模型	团队自制（AI 图生 3D）	`public/models/rabbit.glb`，以网络公开 2D 插画为参考，经在线图生 3D 平台生成，仅用于本项目形象演示；加载失败时回退到程序化占位模型

科普内容（90 条疾病、73 种药品）由团队依据公开诊疗指南与药品说明书整理， 每条标注来源与整理月份，正文不含任何处方建议，页面底部固定一句"科普不替代面诊"。 界面中的插图（18 组科室线稿）为团队自绘 SVG，不含第三方图片素材。

附录 B　运行方式与演示账号

项目	说明
运行环境	Node.js ≥ 20；Windows 双击 `Start MedAI.bat`， 或 `npm ci && npx prisma generate && npx prisma db push && npm start`
默认端口	生产 3100（`npm start -- -p 3100`）；开发 3200
演示账号	`demo@medai.local` / `Medai@2026` （含 6 份家庭成员档案、在服药物与问诊记录）
无 Key 演示	`.env` 里 `MEDAI_DEMO_AI=1` 时走本地模拟流，协议与真实调用一致
一键体验	`MEDAI_DEMO_LOGIN=1` 时登录页出现"用演示账号直接进去"
环境变量	见仓库根目录 `.env.example`，含数据库、会话密钥、模型、保留天数全部配置项

源码规模：约 2.7 万行（TypeScript / TSX / JS，不含依赖与构建产物）；23 个 API 路由；90 + 73 条科普内容。